

Krótką *interwencja*

Sześć kroków rozmowy o piciu. Pięć do piętnastu minut. Działa najlepiej u osób z piciem ryzykownym — zanim pojawi się ciężka zależność.

CZAS: 10–15 min 1 sesja **ŹRÓDŁO:** Miller & Sanchez (1994); Kaner i wsp. (2018, Cochrane)

JAK UŻYWAĆ

To narzędzie wypełnia się **razem z terapeutą lub lekarzem**. Sześć kroków modelu FRAMES (akronim angielski) odpowiada sześciu sekcjom poniżej. W każdej sekcji jest miejsce na *wynik AUDIT, jasną radę kliniczną, menu opcji do wyboru* oraz *konkretny pierwszy krok*, który zabierasz ze sobą do domu. Spotkanie kontrolne ustalasz na koniec.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Krótką interwencja jest najbardziej kosztowo-efektywną interwencją w medycynie uzależnień. Kaner i wsp. (2018, meta-analiza Cochrane, 34 RCT, N≈10 000): siła efektu **d = 0.30**, redukcja o ~38 g alkoholu/tydzień (≈4 drinki mniej). NNT≈8 — co ósma osoba odnosi mierzalną korzyść. Działa, ponieważ łączy **autonomię** pacjenta (to Twoja decyzja), **empatię** (nie wykład) i **spersonalizowany feedback** z konkretnego badania.

01 ☺ F • Feedback — co mówi mój wynik

AUDIT (ang. Alcohol Use Disorders Identification Test) — 10 pytań WHO o picie i jego konsekwencje. Wynik 0–7 to picie niskiego ryzyka, 8–15 — picie ryzykowne, 16–19 — szkodliwe, ≥20 — prawdopodobne uzależnienie. Wpisz swój wynik i co on dla Ciebie znaczy.

MÓJ WYNIK AUDIT

STREFA RYZYKA

— niskie, ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie

02 🗨 R • Responsibility + A • Advice

R • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

„To Twoja decyzja, co zrobisz z tą informacją. Nikt nie może podjąć jej za Ciebie. Mogę przedstawić opcje i poprzeć Cię w wybranej drodze.”

A • RADA KLINICZNA

„Z medycznego punktu widzenia zalecam **ograniczenie picia** do poziomu niskiego ryzyka WHO: ≤2 drinki/dzień (M), ≤1 (K), min. 2 dni bez alkoholu w tygodniu.”

03 📋 M • Menu — wybierz strategie, które chcesz wypróbować

☐ **Dziennik picia** — codziennie zapisuj, ile i kiedy. Sama obserwacja zmniejsza ilość.

☐ **Limit dzienny** — ustal konkretną liczbę (np. 2 drinki) i trzymaj się jej.

☐ **Dni bez alkoholu** — wyznacz 3 dni w tygodniu jako „suche” i pilnuj ich.

☐ **Przeplatanie** — co drugi drink zamień na wodę albo piwo bezalkoholowe.

☐ **Unikanie wyzwalaczy** — zidentyfikuj sytuacje (osoby, miejsca, godziny) i unikaj.

☐ **Aplikacja monitorująca** — np. „Try Dry”, „I Am Sober” — codzienne zapisy w telefonie.

☐ **Wsparcie bliskiej osoby** — powiedz komu zaufanemu o swoim planie redukcji.

☐ **Kolejna konsultacja** — umów wizytę kontrolną za 4 tygodnie.

04 E • Empathy + S • Self-efficacy

E • EMPATIA

„Zmiana nawyków alkoholowych jest trudna — to absolutnie normalne, że potrwa, zanim uda się utrzymać kierunek. Nie jesteś w tym sam/-a.”

S • SKUTECZNOŚĆ WŁASNA

„Wiele osób z podobnym wynikiem AUDIT skutecznie ograniczyło picie. Masz zasoby, których jeszcze nie wykorzystałeś/-aś. Wierzę, że potrafisz.”

05 Mój plan na najbliższe 4 tygodnie

MÓJ CEL

— ile drinków tygodniowo i ile dni bez alkoholu

TRZY STRATEGIE Z MENU, KTÓRE WYBIERAM

NAJBLIŻSZA SYTUACJA, W KTÓREJ BĘDZIE MI TRUDNO

— i co zrobię

DATA SPOTKANIA KONTROLNEGO

OSOBA, KTÓREJ POWIEM O MOIM PLANIE

Klucz: Krótka interwencja działa, gdy pacjent *wybiera*, a nie kiedy jest namawiany. Brzmi paradoksalnie, ale meta-analiza *Kanera* (2018) pokazuje: każda minuta nadwyżki w rozmowie powyżej 15 min **obniża skuteczność**. Mniej znaczy więcej — wystarczy spersonalizowany feedback, jasna rada, menu opcji i Twoja decyzja. $NNT \approx 8$ — co ósma osoba istotnie ogranicza picie po jednej takiej rozmowie.